Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
“___” _____ 2025 йилдаги
_____-сон буйруғига
____-илова

.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН КАРДИОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

“ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМИ” НОЗОЛОГИЯСИ БУЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР

ТОШКЕНТ – 2025

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Узбекистан Республикаси Соғлиқни
Сақлаш вазири
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 й .

“ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМИ” НОЗОЛОГИЯСИ БУЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР

ТОШКЕНТ-2024



«КЕЛИШИЛГАН»
РИКИАТМ директори
Х.Ғ. Фозилов
_____
"____" _____ 2025 йил

“ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМИ” НОЗОЛОГИЯСИ БУЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР

ТОШКЕНТ 2025

ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМИ

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

ХКТ-10 бўйича кодланиши:	**Нозологик номланиши:**	**Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**		**Нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
I20.0, I20.9	Ностабил стенокардия	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенцион кардиолог/реаниматолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I21, I21.0, I21.1, И21.2, I21.3, I21.4, I21.9	Ўткир миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенцион кардиолог/реаниматолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9	Қайта миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенцион кардиолог/реаниматолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8	Миокард инфарктнинг асоратлари	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог,	Кардиолог/Интервенцион кардиолог/реаниматолог	Интервенцион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог,

			эндокринолог, нефролог, окулист		эндокринолог, нефролог, окулист

ХКТ-11 бўйича кодланиши:	**Нозологик номланиши:**	**Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**		**Нозология бўйича статсионар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
BA40.0	Ностабил стенокардия	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
БА41	Ўткир миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA41.0	ST сегмент элеватсияси билан кечувчи ўткир миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA41.1	ST сегменти элеватсиясисиз кечувчи ўткир миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог,	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог,

			ендокринолог, нефролог, окулист		ендокринолог, нефролог, окулист
BA41.3	Жойлашуви ноаниқ ўткир миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA42	Асорат сифатидаги миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
БА42.0	Асорат сифатидаги миокард инфаркти, STEMI	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA42.1	Асорат сифатидаги миокард инфаркти, NSTEMI	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA42.3	Асорат сифатидаги аниқланмаган миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист

BA43	Миокард инфарктига олиб келмайдиган коронар тромбоз	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA43	Аниқланмаган ўткир юрак ишемик касаллиги	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA50	Ески миокард инфаркти	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист
BA60, BA60.0, BA60.1, BA60.2, BA60.3, BA60.4, BA60.5, BA60.6, BA60.7, BA60.8, BA60.9, BA60.Й, BA60.3	Ўткир миокард инфарктидан кейинги жорий асоратлар	УАШ/Терапевт/Кардиолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенсион кардиолог/реаниматолог	Интервенсион кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, ендокринолог, нефролог, окулист

***стандартни тўлдириш жараёнида нозология, унинг катталар, хомиладорлар, болалар ва қарияларда кечуви ҳамда нозология бўйича касалликни даври хусусиятидан келиб чиқиш талаб этилади.**

Шунингдек, нозология га тўғри келмайдиган жадвалларни тўлдириш тавсия қилинмайди. (Мисол учун, жаррохлик амалиёти нозологиясида ўтказилмаса (ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ) жадвали тўлдирилмайди ёки нозологияда паллиатив даво кўзда тутилмаса – (ПАЛЛИАТИВ ДАВО) жадвали тўлдирилмайди.

ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Оилавий шифокор	+						Амбулатор кузатув умрбод; Стационар даволаниш: 10-14кун*
	2. Кардиолог		+	+	+	+		
	3. Терапевт			+				
Изоҳ: * стационар шароитидаги даволаниш муддати бўлган госпитализация мақсадига боғлиқ. Стационар шароитидаги мутахассис кўриклари ҳар кунги бўлади.								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Интервенцион кардиолог			+	+	+	Кўрсатмага кўра	
	2. Кардиожарроҳ				+	+	Кўрсатмага кўра	
	3. Интервенцион аритмолог					+	Кўрсатмага биноан	
	4. Невропатолог			+	+	+	Кўрсатмага биноан	
	5. Эндокринолог			+	+	+	Кўрсатмага биноан	
	6. Нефролог			+	+	+	Кўрсатмага биноан	
	7. Окулист			+	+	+	Кўрсатмага биноан	
Изоҳ: Барча тор мутахассислар кўриги кўрсатмага биноан ташкиллаштирилади. Стационар шароитада тор мутахассисларнинг кўрик сони клиник ҳолатига мувофиқ ташкиллаштирилиши лозим.								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Умумий қон таҳлили			+	+	+	Кўрсатмага кўра	
	2. Умумий сийдик таҳлили			+	+	+		
	3. Қондаги креатинин			+	+	+		
	4. АЛТ, АСТ, билирубин			+	+	+		

	5. Қондаги қанд			+	+	+		
	6. Умумий холестерин			+	+	+		
	7. Триглицеридлар			+	+	+		
	8. ЮЗЛП-Хс			+	+	+		
	9. ПЗЛП-Хс			+	+	+		
	10. Умумий КФК			+	+	+		
	11. Коагулограмма			+	+	+		
	12. Тропонинлар			+	+	+		
Изоҳ: агар ОШП/ОП моддий-техник базаси тўлиқ липид спектри билан умумий КФК текшириш имкоянитига эга бўлса, оилавий шифокор томонидан бу текширувлар бажарилиши лозим. Стационар шароитида лаборатор текширувларнинг сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади.								
Қўшимча лаборатор текширувлар	1. МВ-КФК			+	+	+	Кўрсатмага кўра	
	2. PW			+	+	+		
	3. Қон гуруҳи			+	+	+		
	4. Гепатит В ва С			+	+	+		
	5. ОИВ			+	+	+		
	6. МНУП			+	+	+		
	7. ТТГ			+	+	+		
	8. Гликирланган гемоглобин			+	+	+		
	9. Электролитлар			+	+	+		
	10. Умумий оқсил			+	+	+		
	11. Кислота-ишхорлик мувозанатини бахолаш							
Изоҳ: Қон гуруҳи, гепатит В ва С, ОИВ га текширувлар КАГ ва/ёки миокард реваскуляризацияси (ТОКА ёки АКШ) режалаштирилган беморлар учун бажарилиши лозим. Стационар шароитида лаборатор текширувларнинг сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади.								
Асосий инструментал текширувлар	1. ЭКГ			+	+	+	Кўрсатмага кўра	
	2. ЭхоКГ			+	+	+	1-та, кейин кўрсатмага кўра	
	3. Инвазив коронарография				+	+	кўрсатмага кўра	

Изоҳ: Стационар шароитида ЭКГни сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади.								
Қўшимча инструментал текширувлар	**1. Кўкрак қафаси рентгенографияси**			**+**	**+**	**+**		
	2. Уйқу артериялари УТТ			**+**	**+**	**+**		
	3. Холтер бўйича ЭКГ ни мониторлаш				**+**	**+**		
	4. Фракцион қон оқим захираси (ФФР)					**+**		
	5. ЭГДФС			**+**	**+**	**+**		
	6. Ички аъзолар УТТ			**+**	**+**	**+**		
Изоҳ: ЭГФДС гастродуоденал қон кетишининг мутлақ белгилари мавжуд бўлса, интенсив терапияда бажарилиши керак.								

Диагностик тадбирлар	**Тиббий хизматлар номи**	**Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича**					**Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони**	**Даволаш муддати**
		Амбулатор ёрдам		**Стационар ёрдам**				
		ОШП/ОП	**КТМП**	**Туман (шаҳар) шифохоналари**	**Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари**	**Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари**		
Бошқа турдаги текширувлар	**1. ТИМИ шкаласи**			**+**	**+**	**+**	**Биринчи кўрикда**	
	2. ГРАСЕ шкаласи			**+**	**+**	**+**	**Биринчи кўрикда**	
	3. ЧА2ДС2-ВАСс ва ҲАС-БЛЕД шкалалари			**+**	**+**	**+**	**Ҳар кўрикда**	
	4. СЙНТАХ ссоре			**+**	**+**	**+**	**КАГ ўтказилгандан сўнг миокард реваскуляризация турини аниқлашда қўлланилади**	
Изоҳ: Тестдан олдинги эҳтимоллик барча беморларда текширув жаройинадан олдин баҳоланиши лозим. **Шкала ТИМИ (Тҳромболйсис Ин Мёсардиал Инфарстион) кўрсаткичи ўткир коронар синдромли беморларда юрак-қон томир касалликлари хавфини баҳолаш учун ишлатилади.** **Шкала ГРАСЕ (Глобал Регистрй оф Асуте Соронарй Евентс) шкаласи клиник маълумотлар ва текширув натижаларини ҳисобга олган ҳолда ўткир коронар синдромли беморларнинг прогнозини баҳолаш учун ҳам қўлланилади..** **ЮИК ва бўлмачалар фибрилляцияси бўлган беморлар ишемик инсульт хавфини баҳолаш учун ЧА2ДС2-ВАСс шкаласи қўлланилади.**								

ЮИК ва бўлмачалар фибрилляцияси бўлган беморлар орал антикоагулянтлар қўлланилганда қон кетиш эҳтимоллигини баҳолаш учун ҲАС-БЛЕД шкаласи қўлланилади.
СЙНТАХ шкаласи коронар артерияларининг шикастланишини анатомик мураккаблигини баҳолаш ва аортокоронар шунтлаш ёки балон ангиопластикасидан ўтган беморларда натижаларни башорат қилиш учун ишлатилади..

(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез-тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
1. Антиагрегантлар - Ацетилсалицил кислотаси - Клопидогрел - Тикагрелор - Прасугрел	Ацетилсалицил кислотаси нагрузочная доза 150-300 мг, кейин 75-150 мг дан 1 марта суткасига	+	+	+	+	+	75-150 мг	умрбод
	Клопидогрел нагрузочная доза 300 мг, бемор >75 ёш - 75 мг. 75 мг 1 марта суткасига ёки	+	+	+	+	+	75 мг	1 йил*
	Тикагрелор нагрузочная доза 180 мг, кейин 90 мг 2 марта суткасига ёки			+	+	+	180 мг	1 йил*
	Прасугрел 5-10 мг 1 марта суткасига			+	+	+	5-10 мг	1 йил*

2. Антикоагулянтлар: **- Фракциярланмаган гепарин** **- Эноксапарин**	**- Фракциярланмаган гепарин (ФНГ) болюс 60-70 ЕД/кг (лекин 5000 ЕД-дан куп эмас) в/и, кейин в/в инфузия бошлангич тезлиги 12-15 ЕД/кг/ч (лекин 1000 ЕД/кг/ч дан куп эмас). Кейин, доза ҚФТВ бўйича таърифланади, у контрол вақтини 1,5-2,5 марта ошиши керак бўлади.кейин/ёки**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**Согласно инструкции**	**5-7 кун**
	-Эноксапарин 1 мг/кг, 2 марта суткасига т/о			**+**	**+**	**+**	**Согласно инструкции**	**-**
3. тромболитиклар[6]	**Стрептокиназа 1 500 000 МЕ** **Тенектеплаза 40 мг (8 000 ЕД/ 50 мг (10 000 ЕД)**			**+**	**+**	**+**	**-**	**-**
4. Диуретиклар[1]	**Фуросемид 10 мг/мл (амп 2 мл)** **Фуросемид таб. 40 мг** **Торасемид 20 мг/4 мл** **Торасемид таб. 5 мг, 10 мг**			**+**	**+**	**+**	**Кўрсатмага кўра**	**-**
5. Узоқ таъсир қилувчи нитратлар: **- Изосорбид**	**Нитроглицерин а)0,1-1,2 мг фақат стенокардия**			**+**	**+**	**+**	**Кўрсатмага кўра**	**-**

динитрат[2,5]	хуружларида тил остига ё таблетка ё спрей кўринишида қўлланилади б) ампула 0,1%-10 мл Изосорбид динитрат 0,1%-10 мл							
6. Антиаритмические препараты, класс ИИИ[2,3] Амиодарон	Амиодарон 150 мг /3 мл Амиодарон 150 мг. Лидокаин 20 мг/мл Эсмолол 10 мг/мл			+	+	+	Кўрсатмага кўра	
7. Адренергические и дофаминергические средства[1,5]	Добутамин 250 мг/50 мл Допамин 40 мг/мл Норэпинефрин 2 мг/мл Эпинефрин (адреналин) 1 мг/мл			+	+	+	Кўрсатмага кўра	
8. Наркотик анальгетиклар[2] -	-Морфин 10 мг/1 мл -Промедол 10 мг/1 мл Фентанил 50 мкг/1 мл	+	+	+	+	+	Кўрсатмага кўра	
9. Алкалоиды белладонны третичные амины	Атропина сульфат 0,1% 1 мл[4]			+	+	+	Кўрсатмага кўра	-
10. Статинлар - Розувастатин - Аторвастатин	- Розувастатин 5-40 мг дан 1 марта суткасига - Аторвастатин 10-80 мг дан 1 марта суткасига			+	+	+	- Розувастатин 5-40 мг - Аторвастатин 10-80 мг	умрбод
11. РААТ блокаторлари[7]:	ААФи:			+	+	+	ААФи:	умрбод

А) ААФ ингибиторлари: **- Эналаприл** **- Рамиприл** **- Периндоприл** **Б) АРБ (сартанлар):** **- Валсартан** **- Лозартан** **- Кандесартан** **- Телмисартан** **- Азилсартан** **- Олмесартан**	**- Эналаприл 2,5-20 мг кунлик дозаси 2 марта суткасига бўлиниб берилади** **- Рамиприл 2,5-10 мг 1 марта суткасига** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 марта суткасига** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 марта суткасига** **АРБ:** **- Валсартан – 40-320 мг кунлик дозаси 2 марта суткасига бўлиниб берилади** **- Лозартан 25-100 мг 1 марта суткасига** **- Кандесартан 4-32 мг 1 марта суткасига** **- Телмисартан 10-80 мг 1 марта суткасига** **- Азилсартан 20-80 мг 1 марта суткасига** **- Олмесартан 10-40 мг 1 марта суткасига**						**- Эналаприл 2,5-20 мг** **- Рамиприл 2,5-10 мг** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг** **АРБ:** **- Валсартан – 40-320 мг** **- Лозартан 25-100 мг** **- Кандесартан 4-32 мг** **- Телмисартан 10-80 мг** **- Азилсартан 20-80 мг** **- Олмесартан 10-40 мг**	
12. Бета-блокаторлар: **- Бисопролол** **- Метопролол** **- Небивалол** **- Карведилол**	**- Бисопролол 2,5-10 мг 1 марта суткасига** **- Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 марта суткасига** **- Небивалол 2,5-10 мг 1 марта суткасига** **- Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси**			**+**	**+**	**+**	**- Бисопролол 2,5-10 мг** **- Метопролол сукцинат 25-100 мг** **- Небивалол 2,5-10 мг** **- Карведилол 3,125-25 мг**	**умрбод**

	2-3 марта суткасига бўлиниб берилади							
13. Дегидропиридинли кальций каналлари блокаторлари: - Амлодипин - Лерканидипин - Узоқ таъсир қилувчи нифедипин	- Амлодипин 2,5-10 мг 1 марта суткасига - Лерканидипин 5-20 мг 1 марта суткасига - Нифедипин ретард 30-60 мг 1 марта кунига			+	+	+	- Амлодипин 2,5-10 мг - Лерканидипин 5-20 мг - Нифедипин ретард 30-60 мг	умрбод
14. АМКР: - Спиронолактон - Эплеренон	- Спиронолактон 25-100 мг, 1-3 марта суткасига - Эплеренон 25-50 мг, 1 марта суткасига	+	+	+	+	+	- Спиронолактон 25-200 мг - Эплеренон 25-50 мг	марта суткасига

Изоҳ: * 1 йиллик қўллаш муддати ЎКС, ТОКА ёки АКШ амалиётларини ўказган беморлар учун

[1]Уткир юрак етишмовчилигида, и/или с гемодинамической нестабильностью қўлланилади.

[2]Дори воситаларини таърифлаш схемаси, кўрсатмалар ва касалликнинг оғирлигига кўра.

[3]Қоринчалар экстрасистолияси, Лаун бўйича 4А, 4Б, 5 синфи бўлса қўлланилади.

[4]Брадикардияда гемодинамик нестабиллик билан йўлланган ҳолларда билан берилсин.

[5]Нитратлар инфузияси қўлланилади юрак йўқолиши юқоридаги ҳолатлари ва/ёки сақланиб турган миокард ишемияси ва/ёки гипертензия.

[6]Тромболитик терапия кўрсатмаларга биноан олиб борилади (протоколга қаранг)

[7]РААТ блокаторлари ЮИК бор беморларда АГ, ҚД ва СЮЕ бўлса қўлланилади.

Гепариннинг ҳаддан ташқари дозаси бўлса, кўрсатмаларга мувофиқ протамин сулфат 10 мг / мл дан фойдаланинг.

Беморни даволаш жараёнида юқорида кўрсатилмаган дори воситаларидан фойдаланиш эҳтиёжи юзага келганда, консилиум асосида киритилиши мумкин.

Агар ЎҚС клиник маълумотлар ва ЭКГ асосида амбулатор шароитида шубҳа қилинган бўлса, унда амбулатория даражасидан биринчи ёрдам кўрсатиш керак.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
1. Ривароксабан	2,5 мг 2 марта суткасига			+	+	+	5 мг	умрбод**

2. Апиксабан	**2,5-5 мг 2 марта суткасига**			**+**	**+**	**+**	**5-10 мг**	**1 йил**
3. Фенофибрат	**145 мг 1 марта суткасига**			**+**	**+**	**+**	**145 мг**	**умрбод**
4. Омега 3	**1 г 2 та капсуладан 2 марта суткасига**			**+**	**+**	**+**	**4 г**	**умрбод**
5. Ингибиторы протонного насоса **- Омепразол** **- Пантопразол** **- Рабепразол** **- Эзомезопразол**	**-Омепразол 20 мг 1 марта суткасига** **-Пантопразол 40 мг1 марта суткасига** **-Рабепразол 20 мг1 марта суткасига** **-Эзомепразол 20 мг марта суткасига**			**+**	**+**	**+**	**-Омепразол 20 мг 1 марта суткасига** **-Пантопразол 40 мг1 марта суткасига -** **Рабепразол 20 мг марта суткасига** **-Эзомепразол 20 мг марта суткасига**	**1 ой***
6. Триметазидин	**80 мг 1 марта суткасига, 35 мг 2 марта суткасига**			**+**	**+**	**+**	**70-80 мг**	**умрбод**
7. Ранолазин	**500-1000 мг 2 марта суткасига**			**+**	**+**	**+**	**1000-2000 мг**	**умрбод**
8. Метаболиклар[2]: **- Фруктоза-1,6-дифосфат[2]** **- Фосфокреатин[2]** **- мельдоний** **- тиотриазолин**	**Дори воситаларини таърифлаш схемаси, кўрсатмалар ва касалликнинг оғирлигига кўра**							
9. Минерал препаратлар, микроэлементлар[2]. **- Калия хлорид 40мг/мл** **- Магния сульфат250 мг/мл**	**Дори воситаларини таърифлаш схемаси, кўрсатмалар ва касалликнинг оғирлигига кўра**							
10. Регидратация ва	**Дори воситаларини**							

дезинтоксикация учун препаратлар **- Глюкоза**	**таърифлаш схемаси, кўрсатмалар ва касалликнинг оғирлигига кўра**							

Изоҳ: Эзетимиб, Инклисиран гиполипидемик довосида 2 ва 3 қатордаги дори ҳисобланиб, статинларнинг самадорлиги етмаганда қўшилади.
Фенофибрат ва Омега 3 дори воситалари гиперхолестеринемия билан гипертриглицеридемия бирга келганда қўлланилади
Верапамил ёки Дилтиазем бета-блокатор қўллаш мумкин бўлмаган ҳолларда (бронхиал астма, аллергик реакциялар ва б.) тавсия қилинади
*** Клопидогрелни 1 йиллик қўллаш муддати ЎКС, ТОКА ёки АКШ амалиётларини ўказган беморлар учун. Агар СЮИК беморида юрак қон-томир хавфи юқори бўлса, ацетилсалицил кислотаси билан бирга умрбод қўлланилиши мумкин.**
**** Ривароксабан 2,5 мг дан 2 маҳал коронар ҳавзаси кўп томирли шикастланиши бўлганда, ацетилсалицил кислотаси билан бирга умрбод қўлланилиши мумкин. Агар СЮИК ли беморда БФ бўлса, ривароксабан 15-20 мг дан суткасига берилади.**
Беморни даволаш жараёнида юқорида кўрсатилмаган дори воситаларидан фойдаланиш эҳтиёжи юзага келганда, консилиум асосида киритилиши мумкин.

(ОПЕРАТИВ ДАВОЛАШ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	**Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича**				
	Амбулатор ёрдам		**Стационар ёрдам**		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	**ОШП/ОП**	**КТМП**	**Туман (шаҳар) шифохоналари**	**Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари**	**Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари**
1. Тери орқали коронар аралашув (ТОКА)			**+**	**+**	**+**
2. Коронар шунтлаш (КШ)				**+**	**+**
3. Вақтинчалик юрак стимулятори			**+**	**+**	**+**
4. Аорта ичидаги балон контрапулсацияси					

Изоҳ: ТОКА: агар коронар ҳавзаси 1 ёки 2 томирли шикастланиш (СЙНТАХ натижаси 32 баллдан паст) бўлса ва оптимал медикаментоз терапияси самара етарли бўлмаса
КШ: агар коронар ҳавзасида 3 ва кўп томирли шикастланиш (СЙНТАХ натижаси 32 баллдан юқори) бўлса, ёки чап тож артерия ўзани шикастланиши билан, ёки ёндош ҚД бўлса
Вақтинчалик юрак стимулятори: ҳаётга хавф туғдирадиган аритмия ва асистолия хавфи ортиши билан кечадиган ўткир клиник ҳолатларда.
Аорта ичидаги балон контрапулсацияси: чап қоринча етишмовчилиги билан кечадиган ҳолатлар: кардиоген шок, қоринча тахикардияси ва бошқалар.

(ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ/ДИЕТА)

Овқатланиш тартиби	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Парҳез столи ва унинг давомийлиги	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. 10-сонли стол умрбод	+	+	+	+	+

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Ҳамшира	+		Кўрсатмага кўра мутахассис томонидан аниқланади	Агар бемор ЎМИ, ТОКА ва АКШ ўтказган бўлган бўлса, реабилитация 1 йил давомида ўтказилиши лозим.
	2. Оилавий шифокор	+			
	3. Кардиолог		+		
	4. Терапевт		+		
	5. Диетолог		+		
	6. Физиотерапевт		+		
	7. Тиббий психолог		+		
Изоҳ: Барча тор мутахассислар кўриги кўрсатмага биноан ташкиллаштирилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Умумий қон таҳлили	+	+	Шифокор кўригидан сўнг кўрсатмага биноан тавсия этилади.	
	2. Умумий сийдик таҳлили	+	+		
	3. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+		
	4. Липид спектри	+	+		
	5. Қондаги қанд миқдори	+	+		
	6. Креатинин	+	+		
Изоҳ: қон таҳлиллар дори воситаларнинг самадорлигини ва хавфсизлигини баҳолаш учун тавсия этилади					
Инструментал текширувлар	1. ЭКГ	+	+	Шифокор кўригидан	

	2. ЭхоКС		+	сўнг кўрсатмага биноан тавсия этилади.	
	3. Холтер бўйича ЭКГ ни мониторлаш		+		
	4. ВЭМ ёки тредмил-синамаси	+	+		
Изоҳ: ВЭМ ёки тредмил-синамаси прогнози юрак-томир риски жисмоний юкламага толерантликни, ва медикаментоз терапияни самарадорлиги баҳолаш учун тавсия этилади.					
Даволаш тадбирлари (медикаментоз даво)		ОШП/ОП	КТМП	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши				
1. Ацетилсалицил кислотаси	75-150 мг дан 1 марта суткасига	+	+	75-150 мг	умрбод
2. Клопидогрел	75 мг 1 марта суткасига	+	+	75 мг	1 йил
3. Статинлар - Розувастатин - Аторвастатин	- Розувастатин 5-40 мг дан 1 марта суткасига - Аторвастатин 10-80 мг дан 1 мартма суткасига	+	+	- Розувастатин 5-40 мг - Аторвастатин 10-80 мг	умрбод
4. РААТ блокаторлари: А) ААФ ингибиторлари: - Эналаприл - Рамиприл - Периндоприл Б) АРБ (сартанлар): - Валсартан - Лозартан - Кандесартан - Телмисартан - Азилсартан - Олмесартан	ААФи: - Эналаприл 2,5-20 мг кунлик дозаси 2 марта суткасига бўлиниб берилади - Рамиприл 2,5-10 мг 1 марта суткасига - Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 марта суткасига - Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 марта суткасига АРБ: - Валсартан – 40-320 мг кунлик дозаси 2 марта суткасига бўлиниб берилади - Лозартан 25-100 мг 1 марта суткасига - Кандесартан 4-32 мг 1 марта суткасига - Телмисартан 10-80 мг 1 марта суткасига - Азилсартан 20-80 мг 1 марта	+	+	ААФи: - Эналаприл 2,5-20 мг - Рамиприл 2,5-10 мг - Периндоприл эрбумин 2-8 мг - Периндопил аргинин 2,5-10 мг АРБ: - Валсартан – 40-320 мг - Лозартан 25-100 мг - Кандесартан 4-32 мг - Телмисартан 10-80 мг - Азилсартан 20-80 мг - Олмесартан 10-40	умрбод

	суткасига - Олмесартан 10-40 мг 1 марта суткасига			мг	
5. Қисқа таъсир қилувчи нитратлар: - Нитроглицерин	Нитроглицерин 0,1-1,2 мг фақат стенокардия хуружларида тил остига ё таблетка ё спрей кўринишида қўлланилади	+	+	0,1-1,2 мг	Фақат стенокардия хуружида
6. Бета-блокаторлар: - Бисопролол - Метопролол - Небивалол - Карведилол	- Бисопролол 2,5-10 мг 1 марта суткасига - Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 марта суткасига - Небивалол 2,5-10 мг 1 марта суткасига - Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси 2-3 марта суткасига бўлиниб берилади	+	+	- Бисопролол 2,5-10 мг - Метопролол сукцинат 25-100 мг - Небивалол 2,5-10 мг - Карведилол 3,125-25 мг	умрбод
7. Дегидропиридинли кальций каналлари блокаторлари: - Амлодипин - Лерканидипин - Узоқ таъсир қилувчи нифедипин	- Амлодипин 2,5-10 мг 1 марта суткасига - Лерканидипин 5-20 мг 1 марта суткасига - Нифедипин ретард 30-60 мг 1 марта кунига	+	+	- Амлодипин 2,5-10 мг - Лерканидипин 5-20 мг - Нифедипин ретард 30-60 мг	умрбод
8. АМКР: - Спиронолактон - Эплеренон	- Спиронолактон 25-100 мг, 1-3 марта суткасига -	+	+	Спиронолактон 25-100 мг, Эплеренон 25-50 мг,	умрбод
Изоҳ: Медикаментоз терапиянинг таркиби касалликнинг оғирлиги ва ёндош касалликлар борлигига қараб ўзгариши мумкин.					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Ҳамшира	+	+	ЎМИ ўтказган беморлар учун	1 йил
	2. Оилавий шифокор				

	3. Кардиолог		+	йилига 4 марта	
	4. Невролог		+		
	5. Эндокринолог		+		
	6. Нефролог		+		
	7. Офтальмолог		+		
Изоҳ: Қайта кўрик мақсадли АҚБ, ПЗЛП баҳолаш ва антиишемик дори воситаларини дозаси титрациялаш учун ташкиллаштириларди. ИВ ФС бўлганда қайта кўриклар сони кўпроқ бўлиши мумкин.					
Лаборатор текширувлар	1. Умумий қон таҳлили	+	+	ЎМИ ўтказган беморлар учун йилига 4 марта	
	2. Умумий сийдик таҳлили	+	+		
	3. Қондаги қанд	+	+		
	4. Қондаги креатинин	+	+		
	5. Липид спектри	+	+		
	6. АЛТ, АСТ, умумий КФК	+	+		
	7. Коагулограмма	+	+		
Изоҳ: Даврий кўрикларда кўрсатмага мувофиқ қўшимча лаборатор текширувлар тавсия қилинади.					
Инструментал текширувлар	1. ЭКГ	+	+	ЎМИ ўтказган беморлар учун йилига 4 марта	
	2. ЭХОКГ		+	Кўрсатмага мувофиқ	
	3. ХМЭКГ		+		
	4. Брахиоцефал артерияларни УТТ		+		
	5. Ички аъзоларни УТТ		+		
	6. Стресс-ЭКГ (ВЭМ, тредмил-синамаси)	+	+		
Изоҳ: Даврий кўрикларда кўрсатмага мувофиқ қўшимча инструментал текширувлар тавсия қилинади.					